智护忆站

使用说明书 —— 照护者端与管理端（v1.1.0）

2026-11-04

目录

1 这是什么 2
1.1 它能做与不做 2
1.2 三个入口 2
2 操作速查 2
3 开始使用 3
3.1 登录与注册 3
3.2 首页一眼看懂 3
4 每日记录 3
4.1 提交一次打卡 3
4.2 今日完成度 4
4.3 删掉记错的一条 4
4.4 身体状态与手动补录 4
5 量表自评 4
5.1 三份量表 4
5.2 答题 4
5.3 结果页 4
6 减压练习 4
7 问答与助手 4
7.1 知识库检索 5
7.2 助手 5
7.3 配额与费用 5
8 结构化互助 5
8.1 拼一句 5
8.2 回应与举报 5
9 我的 5
9.1 导出与注销 6
9.2 研究参与（受试者） 6
10 研究者：运营台 7
10.1 新建研究 7
10.2 处置与留痕 7
10.3 数据导出与回放 7
11 数据与隐私 8
11.1 收集什么 8
11.2 怎么用 8
11.3 研究数据 8
11.4 保留与删除 8
12 常见问题 8
13 版本与支持 8

1 这是什么

智护忆站是一套**给失智症家庭照护者用的记录与支持工具**：把每天的情绪、睡眠、照护时长与生理指标 记下来，合成一个 0–100 的综合压力指数（HPS），按状态给出可以马上做的放松练习； 另有量表自评、照护知识问答与结构化互助。

它同时是一个**研究数据采集平台**：支持按研究分组、盲法、评估窗口与按臂导出，并有独立的运营台供研究者查看与处置。

1.1 它能做与不做

做	不做
记录每日情绪、睡眠、照护时长与生理指标	不做诊断，不出具医学结论
给出 0–100 的压力指数与三档提示	不替代医生、心理咨询师或精神科评估
提供量表自评（ZBI-12 / PHQ-9 / GAD-7）	不做处方、不给药物剂量
按状态推荐放松练习并记录完成情况	不承诺疗效
从照护知识库检索回答，或由助手查询本人数据	不采集摄像头、麦克风或位置
结构化互助：从词库拼句、固定回应	不提供自由文本与评论

一句话边界：这里的数字用于“看见自己最近的状态”，不是医疗判断。出现伤害自己或他人的风险时，请立即拨打 120 或前往急诊；心理援助热线 12356。

1.2 三个入口

- **照护者端（H5）**：`https://care.205716.xyz`，照护者本人使用；
- **微信小程序**：微信内搜索或扫码进入，照护者本人使用；
- **运营台**：`https://care.205716.xyz/admin/`，研究者与运营使用，需超级管理员账号。

2 操作速查

我想……	去哪	怎么做
记录今天的状态	首页	「记录此刻」，选心情、拖滑块、填睡眠与照护时长，然后提交
看今天还缺什么	首页	压力卡下方「打卡 / 生理 / 量表」三项，已完成的显示对勾，点没完成的那项去补
测一次量表	首页「量表自评」	选量表，逐题选择（自动进入下一题），看结果
找点能马上做的事	底部「减压」	按当前状态推荐的练习，点「开始练习」，完成后评分
问一个照护问题	底部「问答」	输入问题后发送；也可用「常见问题」快捷提问
找同路人说一句	底部「互助」	右下「拼一句」，选内置组合或逐项挑词，然后发出
看自己的历史	底部「我的」	压力趋势、30 天摘要、打卡记录、减压与反馈记录
导出或注销	我的 · 我的数据	「导出我的数据」「注销账号」

我想……	去哪	怎么做
参加研究	我的 · 研究参与	输入研究码后点「加入」
研究者建研究	运营台 · 研究	填研究码、名称、评估时间点、分组配比，然后创建

3 开始使用

3.1 登录与注册

1. 打开照护者端，输入邮箱与密码，点「登录」。
2. 没有账号时点「注册一个」：填写邮箱、密码、称呼，注册成功后自动登录。
3. 微信小程序端可用「微信一键登录」；网页端没有这个入口（网页拿不到微信登录凭证）。

登录即表示同意《用户协议》与《隐私政策》。协议可在登录页或「我的」中随时查看。

3.2 首页一眼看懂

首页从上到下依次是：问候与日期、今日压力卡、今日完成度、支持工具、今日记录、身体状态。

压力卡里的四个数字：

位置	含义
大数字	综合压力指数（0–100），越高表示负荷越重
右上角标签	压力平稳 / 压力预警 / 压力偏高 / 数据不足 / 尚未评估
生理 / 心理 / 生活	三个分量的 0–100 得分；未采集显示「–」
下方一句话	当前状态对应的建议（由服务端生成）

为什么会出现「–」：某个分量当天没有数据。缺数据时不会记 0 分，也不会因此显示“平稳”。 如果指数落在平稳区间但缺少分量，分级会显示「数据不足」。

4 每日记录

4.1 提交一次打卡

1. 首页点「记录此刻」（已打过卡时是「再记一次」）。
2. 依次选择或填写：

字段	取值	说明
时段	日间 / 晚间	按提交时间自动判断
心情	1–5	五档表情与文字，选中项加粗并带下划线
焦虑	0–10	滑块
疲惫	0–10	滑块
昨夜睡眠	0–24 小时	数字输入
今日照护	0–24 小时	数字输入
补充说明	最多 500 字（选填）	只用于自己回看，不进入研究导出

3. 点「提交打卡」。提交后当日指数立即重算，压力卡与「今日记录」同步更新。
4. 下次打开表单会带入**上一次的数值**，只需要改动了的部分。

4.2 今日完成度

压力卡下方一行三个勾：**打卡 / 生理 / 量表**。点没有勾的那一项会直接跳到对应位置； 右侧显示连续打卡天数（当天未打卡时从昨天开始算，避免早上打开就“断签”）。

4.3 删掉记错的一条

「今日记录」里每条右下角有「删除」。确认后当日指数会重新计算；删除不可恢复。

4.4 身体状态与手动补录

首页「身体状态」展示 HRV、皮肤电、睡眠质量与活动量，并标注来源：

来源	含义
设备采集	由已登记的蓝牙设备同步
手动录入	自己填写的数值，不是设备测量
合成数据	仅用于功能演示，不是真实测量，不进入研究结论

手动补录在「我的 · 身体状态」：填 HRV、皮肤电、睡眠质量、步数，保存后来源标记为「手动录入」。 至少填一项即可保存。

5 量表自评

5.1 三份量表

量表	看什么	题量
ZBI-12	照护工作对生活、情绪与关系的影响	12 题
PHQ-9	过去两周的情绪与兴趣变化	9 题
GAD-7	过去两周的紧张与担忧	7 题

5.2 答题

选一份量表，逐题选择最接近的一项（选完自动进入下一题），提交后由服务端计分。 客户端只提交答案，分数、分级与建议都在服务端生成，前端不能改分。

5.3 结果页

- 顶部：分数 / 满分、分级标签；
- 「结果说明」：当前分级对应的说明、免责声明与复测建议（平稳建议一个月后复测，其余两周后复测）；
- 自伤条目命中时：额外出现**安全卡**，提供「拨打 12356」按钮与联系家人、前往急诊的建议。

量表结果是筛查提示，不是诊断。历史结果在量表页下方可查。

6 减压练习

「减压」页按当前压力状态推荐练习，分为呼吸放松、冥想练习、音乐疗法、视频指导四类。

1. 看当前状态卡：分级、指数、三色刻度与参考线 40 / 70；
2. 「为您推荐」里选一项，点「开始练习」；
3. 完成后给出 1–5 星评分（可不填备注），记录到「最近记录」。

评分与完成记录会影响“近 30 天摘要”里的干预次数与平均星级，但**不再影响**压力指数 （旧版本曾把干预次数算进指数，现已移除，避免“用得越多压力越高”）。

7 问答与助手

「问答」页顶部有两个页签：**助手** 与 **知识库**。

7.1 知识库检索

不依赖模型：把问题与知识库条目做关键词与 2-gram 匹配，取最相关的几条原文拼接回答。 每条回答都列出出处；没有匹配时会明确说没找到。

7.2 助手

助手由服务端代理外部模型（DeepSeek），可以**只读查询你自己的数据**再回答，例如：

- 「我今天状态怎么样?」：读取今日指数与打卡次数；
- 「这周趋势如何?」：读取近 7 天趋势摘要；
- 「我上次量表多少分?」：读取最近量表结果；
- 照护问题：检索知识库并给出出处。

界面上能看到的约束：

现象	含义
输入框下方「今日剩余 N 次」	每用户每日调用次数上限（默认 20 次）
回答下方「已读取：今日状态」	这一轮实际读了哪些数据
「助手暂时不可用，本条为知识库检索结果」	未配置模型密钥、额度用尽或上游故障，已自动回退
回答底部「有用 / 没用」	反馈会记录，用于评估检索与回答质量

助手不做诊断、不给药物剂量；涉及自伤念头时会给固定求助路径，不再分析数据。

7.3 配额与费用

每人每日有三重上限：**调用次数、token 数、估算费用**；另有全站每日 token 上限，防止单个账号 把总资源用尽。任一上限达到后，当天回退为知识库检索，次日自动恢复。

8 结构化互助

互助区**没有输入框**：句子由平台词库拼接，回应是固定选项。目的是在提供同路人支持的同时， 避免自由文本带来的审核与隐私风险。

8.1 拼一句

1. 底部「互助」，再点右下「拼一句」（列表为空时点「拼第一句」）；
2. 面板顶部是「快速开始」六组内置组合：夜间照护、白天独处、反复提问、认不出我、留一口气、明天再试—— 点一次填满四个槽位并选好分类；
3. 也可以逐项挑：发生在什么时候、那一刻我是、我试过的办法（可不选）、我想对同路人说；
4. 槽位前的序号会在选中后变成对勾；顶部预览实时显示拼好的句子，可「清空」重来；
5. 可选「匿名发出」，点「发出去」。

每个账号每天最多 5 句。四类组合共 4032 种，句子由服务端生成。

8.2 回应与举报

- 固定回应四种：我也是 / 抱抱 / 有用 / 加油。一人一帖一条，可改选，计数实时更新；
- 「举报」需选择原因（暴露隐私 / 攻击他人 / 不合适 / 其他）；同一帖被 3 位不同用户举报后自动隐藏，等待复核；
- 被隐藏的内容对他人不可见，作者本人仍能看到并联系反馈。

9 我的

「我的」是个人数据的汇总页，从上到下：

区块	内容	操作
用户卡	称呼、邮箱、头像	—
帮助与支持	意见反馈、关于、用户协议与隐私政策、退出登录	点击进入
压力趋势	7 天 / 30 天柱状图，点柱看数值，虚线为平均值	切换区间
近 30 天摘要	平均指数、平均效果、干预次数、平均星级、最高一天、三色天数	只读
打卡记录	最近 14 次打卡的时间、情绪、睡眠与照护时长	只读
干预记录	最近完成的练习与星级	只读
反馈记录	自己对程序提交的星级与文字	只读
身体状态	今日四项与来源，支持手动补录	保存
研究参与	研究码入组、分组、依从、下一评估窗口	加入 / 退出
我的数据	参与研究开关、导出、注销	数据权利

9.1 导出与注销

- **导出我的数据**：生成 JSON 包（账号信息、打卡、评分与事件、量表、问答、互助、反馈），弹窗显示集合数与记录条数，可复制 JSON。数据量大时建议通过反馈索取文件。
- **注销账号**：两次确认后删除账号及其全部记录（打卡、评分、量表、问答、互助），不可恢复。

9.2 研究参与（受试者）

1. 在「研究参与」输入研究者发给你的研究码，点「加入」；
2. 加入后显示：研究名称、研究码、协议版本、入组日期，以及分组、入组天数、打卡天数、量表次数；
3. 若研究设置了盲法，分组只显示「已分组」，不显示具体组别；研究者导出时仍有真实组别；
4. 下方显示下一评估窗口（第几天、哪几份量表、截止时间、是否可提交）；
5. 需要退出时点「退出研究」，选择原因。退出后数据保留，按研究方案统计。

10 研究者：运营台

访问 `https://care.205716.xyz/admin/`，用超级管理员账号登录。五个页面按操作顺序排列：

页面	用途	主要操作
概览	今日打卡/生理/量表/评分、待处置举报、已隐藏、问答与朗读用量、研究入组	查看
助手	是否可用、密钥是否配置、今日与近 7 天调用/token/估算费用、Top 用户、tokenizer 状态	查看、跳转配置
研究	研究列表与详情	新建研究、切换状态、查看按臂质量
内容处置	举报与已隐藏队列（含原因）	隐藏 / 恢复（必填理由）
配置	权重、阈值、生理区间、每日配额、助手限额与计价	编辑（服务端校验）、查看历史
数据	数据集导出与回放命令、最近备份	复制命令

10.1 新建研究

1.「研究」中填研究码（3–32 位字母/数字）、研究名称、协议版本；
2. 选择分组可见性：受试者盲法 / 开放分组；
3. 配置评估时间点：相对入组日的第几天、量表（`phq9,gad7,zbi12` 逗号分隔）、允许的窗口天数；
4. 配置分组：代号、名称、配比（如 A/B 各 1）；
5. 创建后为**草稿**；确认无误后在详情页切换为 **active**，受试者才可入组；结题切换为 **closed**。

入组按“已入组人数 / 配比”最小者分配（退出不从分母移除），因此组间比例始终贴近设计配比。

10.2 处置与留痕

「内容处置」里每条内容都能看到举报原因与数量。隐藏或恢复必须填写理由（至少 4 个字符），操作会写入处置记录：操作者、动作、理由、前后状态。研究材料需要举证时以此为准。

10.3 数据导出与回放

在「数据」页复制命令，在服务器上执行：

```
# 数据集（CSV + quality.json + manifest.json）
RESEARCH_HMAC_SECRET=… \
  bun research/dataset.mjs \
  --db pb_data/data.db \
  --out research/out/run1

# 评分回放（不一致时退出码 1）
bun research/replay.mjs --db pb_data/data.db
```

导出目录含 `studies.csv`、`study_arms.csv`、`study_enrollments.csv` 与按臂质量； `manifest.json` 记录 git 提交、迁移清单、算法版本、参数指纹与每文件 sha256。

11 数据与隐私

11.1 收集什么

- 账号信息：邮箱、称呼、登录凭证、可选绑定的微信标识；
- 健康与照护记录：情绪打卡、睡眠与照护时长、生理指标、量表答案与结果、练习记录；
- 互助与反馈：词元组合与拼接结果、固定回应、举报记录、反馈内容与联系方式；
- 问卷与日志：额度计数、必要的访问日志。

11.2 怎么用

用于计算指数、生成趋势与建议、维护互助与回复反馈；用于额度控制与安全防护。不出售个人信息，不将健康数据用于广告。语音朗读会把被朗读的文字发给语音合成服务，不发送账号身份。

11.3 研究数据

- 研究参与**默认关闭**，需在「我的 · 我的数据」或「研究参与」中单独同意；
- 研究导出默认排除自由文本（补充说明、问答原文、互助句子）、联系方式与合成数据，用户标识以不可逆散列值替代；
- 随时可撤回；撤回后不再进入之后生成的数据集，已生成的历史数据集不回改。

11.4 保留与删除

数据在账号存续期间保存；注销后从生产环境删除。备份中的副本按备份保留周期自然过期。

12 常见问题

为什么指数显示「–」或「尚未评估」？ 当天没有记录，或某一分量没有数据。补一次打卡或生理数据后会自动更新。

为什么分级显示「数据不足」？ 有记录但缺少分量，且算出的分数落在平稳区间。系统不会用“缺数据”冒充“平稳”。

为什么问答页没有助手？ 未配置模型密钥，或当日额度用尽，或上游暂时不可用。此时自动使用知识库检索，不影响使用。

为什么互助区不能打字？ 这是有意设计的：句子由词库拼接，避免自由文本带来的审核与隐私风险；表达空间通过组合提供。

为什么删掉打卡后指数变了？ 指数按当日全部数据实时计算，删除会触发重算。

量表能当诊断吗？ 不能。它是筛查工具，结果只用于自我了解；如有困扰请联系专业人员。

13 版本与支持

项	值
版本	1.1.0（2026-11-04）
服务地址	`https://care.205716.xyz`
运营台	`https://care.205716.xyz/admin/`
反馈入口	「我的 · 意见反馈」
紧急电话	120
心理援助热线	12356

本说明书随版本更新；功能与文案以应用内最新版本为准。